

Г.М. Курманова

Центральный военный госпиталь КНБ РК

Состояние тромбоцитограммы у больных пурпурой Шенлейн-Геноха

Аннотация. Острые лейкозы (ОЛ) представляют собой гетерогенную группу опухолевых заболеваний системы крови - гемобластозов, которые характеризуются первичным поражением костного мозга морфологически незрелыми кроветворными (бластными) клетками с вытеснением ими нормальных элементов и инфильтрацией ими различных тканей и органов. Клиническое наблюдение представляет интерес тем, что тромбоз глубоких вен лица явился первичным признаком острого лейкоза. Течение острого лейкоза характеризовалось значительным угнетением всех ростков кроветворения, развитием тяжелых осложнений, в том числе тромбоза глубоких вен лица справа и тромбоза кавернозного синуса

Изучение различных изменений в системе крови при заболеваниях имеют важное диагностическое значение. Количественный состав и морфология клеток крови у человека в норме характеризуется достаточно высокой стабильностью, которая связана с постоянством действия регуляторных механизмов, направленных на поддержание гомеостазиса. Особый интерес вызывает изучение морфофункциональных показателей тромбоцитов при различных заболеваниях крови. Однако о тромбоцитах известно меньше, чем о других форменных элементах, до сих пор нет четкой цитометрической классификации тромбоцитов. В настоящее время широко применяются автоматические анализаторы крови, эритроцитарные параметры которых активно используются клиницистами в диагностике анемий. В то время, как интерпретация тромбоцитограмм не нашла должного применения при автоматизированном анализе крови. В литературе имеются лишь единичные работы, посвященные оценке тромбоцитопоза с помощью анализаторов (Почтарь М.Е., 2003; Колодей СВ. и соавтор., 2001).

Целью исследования явилось изучение тромбоцитарного звена гемограммы у больных пурпурой Шенлейн-Геноха с помощью автоматического анализатора крови.

Методы исследования: количество тромбоцитов и их гистограммы определяли на современном автоматическом полианализаторе крови японской фирмы «SYSMEX». Оценивали следующие показатели кровяных пластинок:

PLT - количество тромбоцитов;

MPV (mean platelet volume) - средний объем тромбоцитов. Этот показатель характеризует размер тромбоцита. Для определения размера тромбоцитов этот показатель является более достоверной, чем визуальная оценка диаметра тромбоцитов крови, который зависит от формы клеток (Колодей СВ. и соавт., 2001);

PDW (platelet distribution width) - ширина распределения тромбоцита по объему, который отражает степень

анизоцитоза тромбоцитов;

P-LCR - уровень больших тромбоцитов.

Качественные показатели тромбоцитов были оценены у 30 обследуемых больных пурпурой Шенлейн-Геноха. В качестве контроля изучали тромбоцитограммы 15 здоровых лиц (таблица 1).

Из таблицы 1 видно, что средний объем тромбоцитов (MPV, fl) достоверно увеличивался при абдоминальной форме до $(9,92 \pm 0,95)$ fl и при смешанной форме - $(9,95 \pm 0,79)$ fl, против контрольных показателей ($p < 0,05$). При остальных формах заболевания достоверных различий не наблюдалось, хотя показатели MPV были несколько выше контрольных результатов. Данная тенденция свидетельствует о возрастании числа «молодых» пластинок в крови.

Таблица 1- Характеристика качественных индексов тромбоцитов у больных пурпурой Шенлейн-Геноха

Клинические формы	M PV, fl m±t	P DW, fl m±t	PLCR, % M ± t
Кожная n=6	8,78 ±0,8 6	11,5 6±1, 56 P<0,05	23,7 6±1, 12 P<0,05
Кожно-суставная n=12	9,12 ±0, 78	11,8 9±0, 73 P<0,05	23,57±0, 98 P<0,05
Абдоминальная n=5	9,92 ±0, 95 P<0,05	13,89±0, 95 P<0,05	25,39±1, 23 P<0,05
Почечная n=2	8,91±0, 67	12,89±1, 01 P<0,05	24,95±1, 15 P<0,05
Смешанная n=5	9,95±0,7 9 P<0,05	12,97±1, 12 P<0,05	24,58±1, 04 P<0,05
Контроль. группа n=15	8,85 ±0, 97	10,91±0, 96	19,21±1, 17

P - достоверность различий по сравнению с контрольной группой.

Ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW, fl) претерпевала выраженные изменения у больных пурпурой Шенлейн-Геноха в сравнение с контролем при всех клинических вариантах заболевания ($p < 0,05$). Степень анизоцитоза тромбоцитов была наиболее выраженнее у больных с абдоминальной формой, при которой PDW

составила ($13,89 \pm 0,95$) fl.

Уровень больших тромбоцитов (P-LCR, %) у всех обследуемых больных был достоверно выше контрольных данных ($p < 0,05$).

Таким образом, для больных пурпурой Шенлейн-Геноха были характерны качественные изменения тромбоцитов в сторону увеличения форм с большим объемом и с анизоцитозом, а также наблюдался несколько увеличенный уровень больших тромбоцитов в крови.

Список литературы

1. Почтарь М.Е., Луговская С.А., Морозова В. Цитохимическая диагностика в лабораторной гематологии /Методическое руководство. Атлас.-М., 2003.
2. Колодей С.В., Розенберг Ю.М., Шурхина Е.Е. Тромбоз, гемостаз и реология.-М., 2001.
3. Колодей С.В., Шурхина Е.Е., Цветаева Н.В. . Гематология и трансфузиология.-М., 2003.

Тұжырым

Г.М. Курманова

Жедел лейкоздың тромбофилиялық маскісі

ҚР ҰҚК орталық әскери госпиталі

Қанның автоматикалық анализаторы қазіргі кезде кең қолданады, клиницистер олардың эритроциттарлы параметрлерін анемияны анықтауда белсенді қолдануда. Бірақ тромбоцитограмманың талда-

уы автоматтандырылған қанның талдауында кең қолданылмады. Шенлейн – Генох пурпурасымен ауыратын науқастардың гемограммасының тромбоциттарлы бөлігін қанның қазіргі кездегі автоматтандырылған жаратылай талдағышында зерттегенде, тромбоциттердің түрлерінің үлкен көлемді болып ұлғаюы жағына және анизоцитоз болуымен сапасының өзгеруі анықталды, сондай – ақ қандағы үлкен тромбоциттердің деңгейі бақылаудағы көрсеткіштерден әлдеқайда жоғары болды.

Түйінді сөздер жедел лейкоз, тромбоз, асқыну.

Summary

G.M.Kurmanova

Central Military Hospital NSC RK

Trombophilic mask acute leukemia

It is now widely used an automatic blood analyzers, erythrocytic parameters of which are widely used by clinicians in the diagnosis of anemia. But the interpretation of trombositogramm did not find proper application with automated blood analysis. In the study of platelet of haemogram in patients with Schonlein Henoch purpura, by the modern automatic semianalizer of blood revealed a qualitative changes in increasing of forms with the high-volume and anisocytosis, and there was an increased level of several large platelets in the blood was significantly higher than the control data.

Key words: acute leukemia, thrombosis, complications